Boletín Epidemiológico N° 02 de 2025

Dirección de Vigilancia de la Salud

Ministerio de Salud

24 de enero de 2025

Tabla de contenido

Arbovirosis 3

Malaria 8

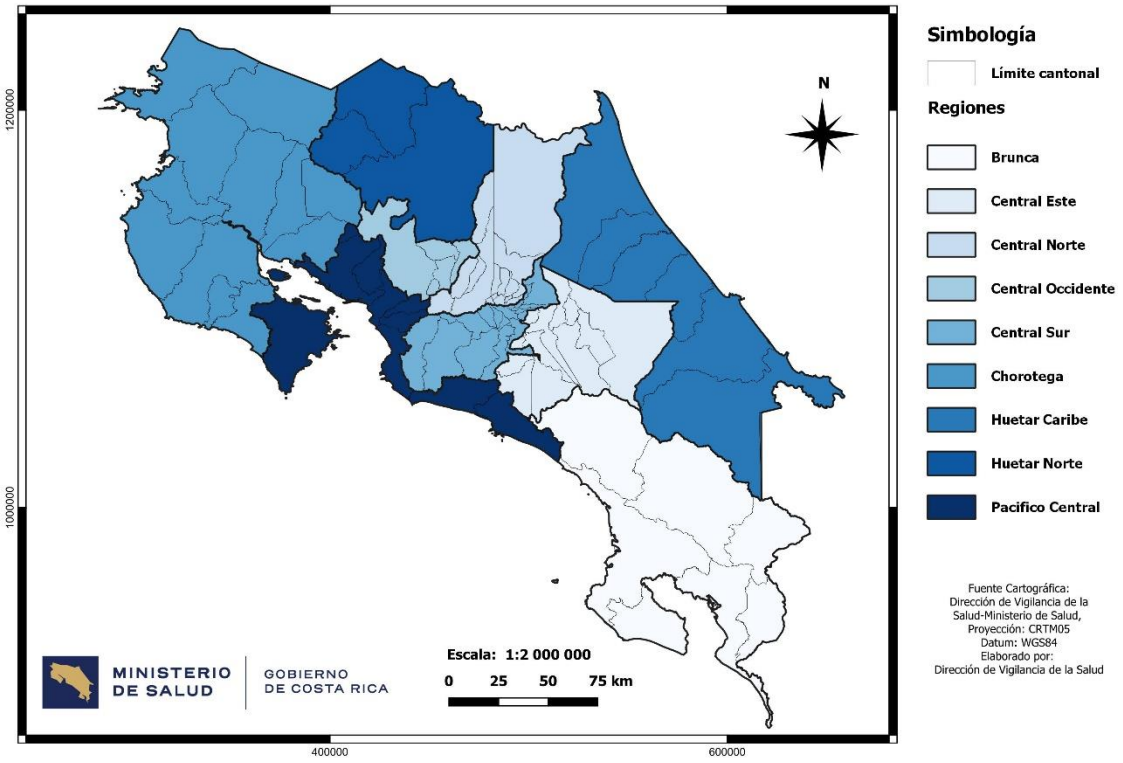
Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19 12

Infecciones de transmisión sexual 26

Miasis por gusano barrenador en humanos 31

Depresiones 36

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024



Arbovirosis

Adriana Alfaro Nájera
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de Salud

Adrián Montero Bonilla
Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Dengue

A la semana epidemiológica 2 del año 2025 se notificaron **215 casos** de dengue.

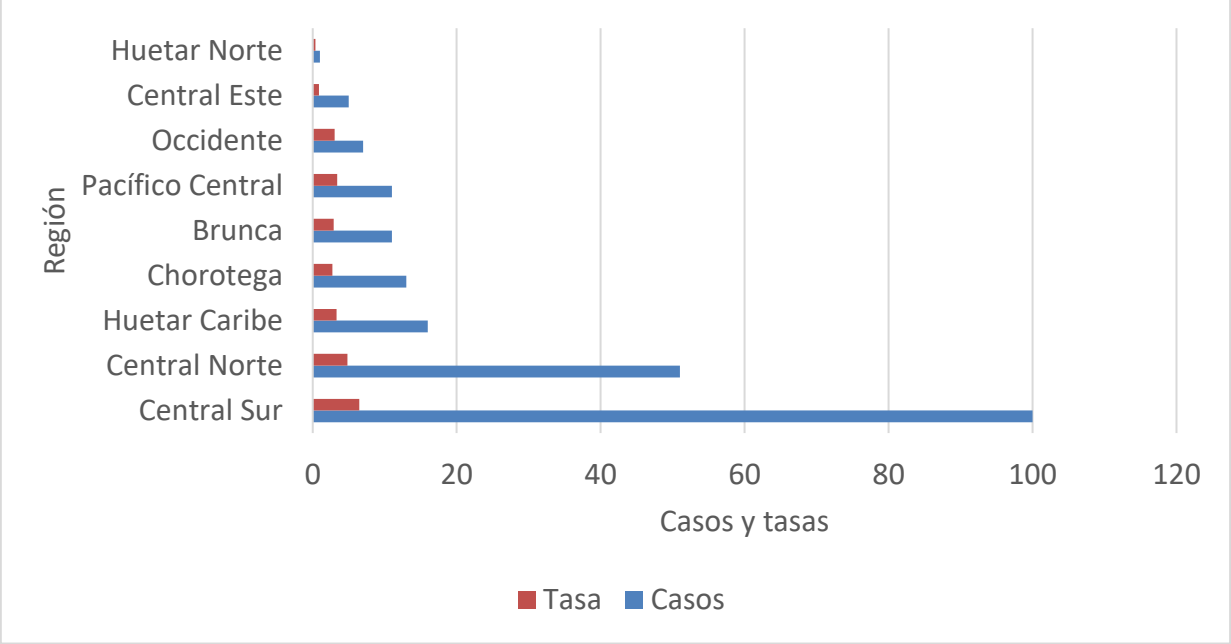
En la región Central Sur se concentra la mayor notificación acumulada con 100 casos y una tasa de 6,4/100.000 habitantes.

Tabla 1.
Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región a la semana epidemiológica 2, 2025 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Central Sur	100	6,4
Central Norte	51	4,8
Huetar Caribe	16	3,3
Chorotega	13	2,7
Brunca	11	2,9
Pacífico Central	11	3,4
Occidente	7	3,0
Central Este	5	0,9
Huetar Norte	1	0,4
Total	215	4,0

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 1.
Costa Rica: casos de dengue y tasa por región a la semana epidemiológica 2, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

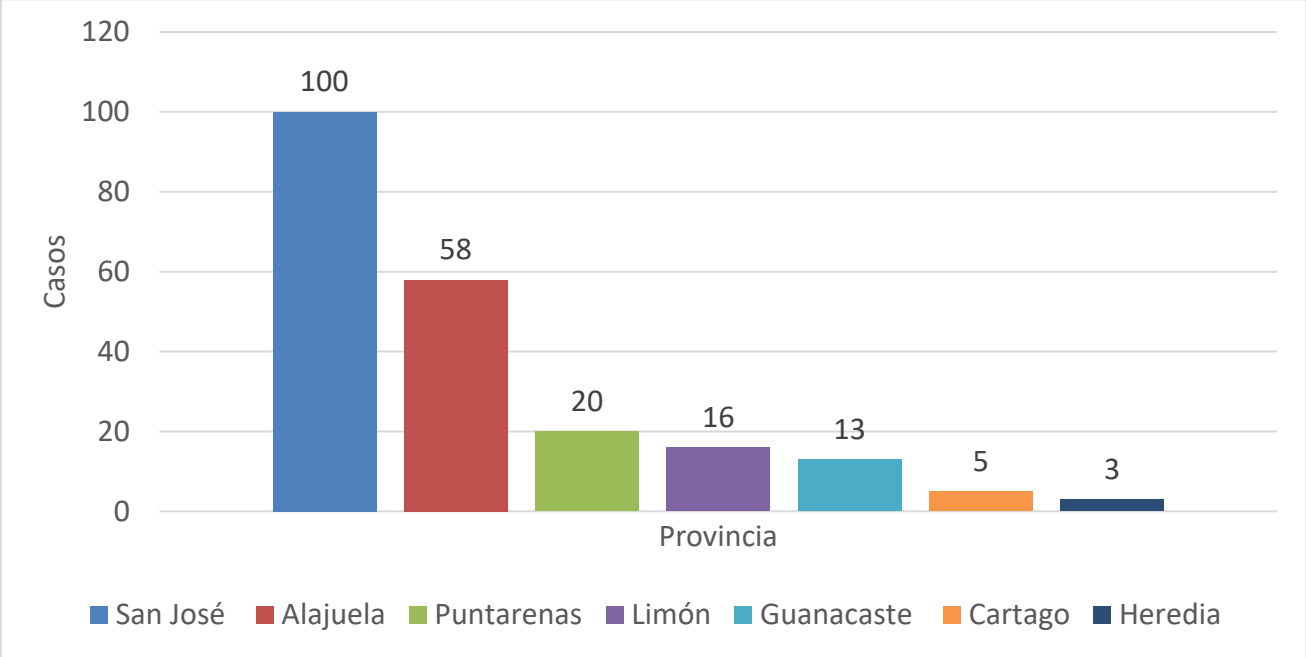
En la tabla 2 se pueden observar los casos notificados por provincia y sexo para el año 2024.

Tabla 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia y sexo, 2025

Provincia	Total casos	Tasa	Femenino	Tasa	Masculino	Tasa
San José	100	5,8	47	5,4	53	6,2
Alajuela	58	5,3	34	6,3	24	4,3
Puntarenas	20	3,8	7	2,7	13	4,9
Limón	16	3,3	4	1,7	12	4,8
Guanacaste	13	3,1	4	1,9	9	4,2
Cartago	5	0,9	1	0,4	4	1,4
Heredia	3	0,5	2	0,7	1	0,4
Total	**215**	**4,0**	**99**	**3,7**	**116**	**4,3**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia a la semana epidemiológica 2, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Los cantones con mayor número de casos acumulados a la semana epidemiológica 2 son: Alajuela 42 casos, San José 36. Alajuelita 27 casos, Tibás 16 casos y Cañas 8 casos.

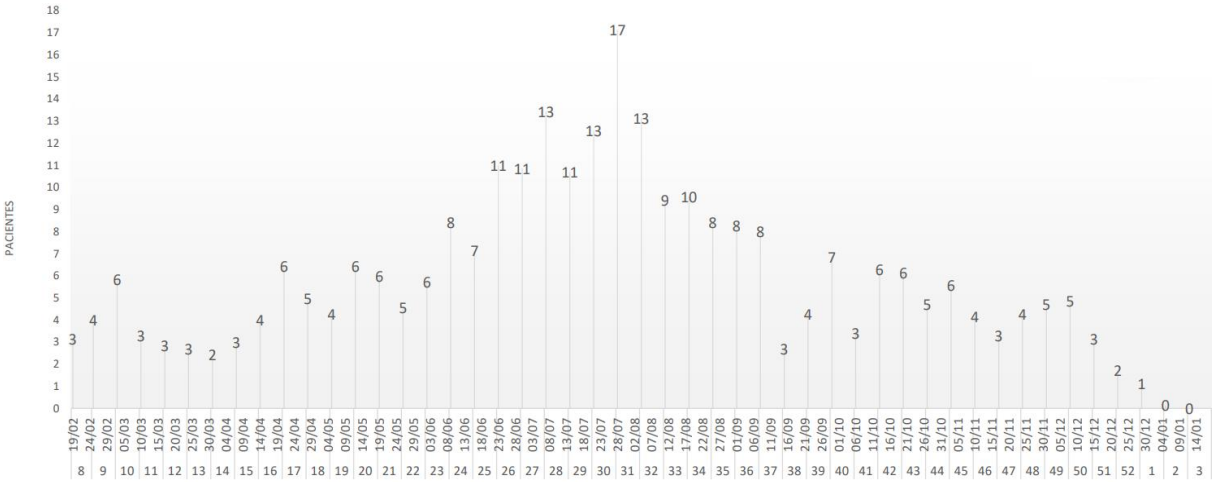
Tabla 3.
Costa Rica: cantones prioritarios en casos de dengue a la semana epidemiológica 2, Costa Rica 2025

Cantón	Casos	Tasa
201: Alajuela	42	12,6
101: San José	36	10,1
110: Alajuelita	27	26,8
113: Tibás	16	18,2
506: Cañas	8	23,3
607: Golfito	8	16,7
703: Siquirres	7	10,5
107: Mora	6	19,1
109: Santa Ana	6	9,4
601: Puntarenas	6	4,0
202: San Ramon	4	4,1
205: Atenas	4	13,0
301: Cartago	4	2,4
701: Limón	4	4,0
108: Goicoechea	3	2,1
705: Matina	3	6,1
103: Desamparados	2	0,8
118: Curridabat	2	2,4
207: Palmares	2	4,6
209: Orotina	2	7,9

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

El Área de Estadística en Salud de la CCSS según los datos recopilados mediante EDUS no se reportan pacientes hospitalizados con dengue al 20 de enero.

Figura 3.
Costa Rica: CCSS. Promedio de pacientes hospitalizados con Dengue según semana epidemiológica.19/02/2024 al 18/01/2025



Fuente: EDUS CCSS, Gerencia Médica, Área de estadística en salud

A la semana epidemiológica 2 del 2025 no se tienen notificaciones de chikungunya ni zika.

Malaria

Isaac Vargas Roldán
Unidad de epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

I. Antecedentes

En las últimas décadas, Costa Rica ha logrado mantener bajos niveles de transmisión de malaria gracias a los esfuerzos continuos y control. Los casos han disminuido notablemente en comparación con el pasado.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) lideran los esfuerzos de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de la malaria, junto con el apoyo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). Se utilizan herramientas para el diagnóstico rápido y monitoreo constante de los casos.

Costa Rica forma parte de la **Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana (IREM)** es un esfuerzo conjunto de varios países y organizaciones internacionales con el objetivo de eliminar la malaria en esta región. Esta iniciativa busca coordinar acciones, compartir recursos y conocimientos, y establecer estrategias comunes para combatir y erradicar esta enfermedad.

El objetivo principal para este año es mantener la reducción sostenida de casos de malaria y avanzar hacia la meta de eliminación. Costa Rica se perfila como el próximo país de la región en obtener la certificación de cero casos autóctonos de malaria.

Como parte de las acciones para alcanzar este objetivo, se están llevando a cabo **supervisiones capacitantes** dirigidas a los funcionarios de la CCSS y el MINSA. Estas supervisiones tienen el propósito de actualizarlos en el manejo de la malaria y fortalecer la implementación de estrategias de control, como la estrategia DTIR, en todo el territorio nacional.

Además, se está priorizando el **fortalecimiento de la red de colaboradores voluntarios** en comunidades con barreras de acceso a los servicios de salud y esfuerzos para acerca el diagnóstico y tratamiento a personas en condición de movilidad humana que llevan su paso por el país.

II. Vigilancia epidemiológica

En la Semana Epidemiológica 01, no se reportan casos confirmados de malaria en el país.

Se ha llevado a cabo un exhaustivo monitoreo a nivel nacional de la malaria, por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud realizando pruebas de diagnóstico mediante búsquedas pasivas y activas de casos.

A semana epidemiológica 01, se registraron 523 pruebas de diagnóstico, las cuales responden a las búsquedas realizadas por las instituciones, desglosadas de la siguiente manera, (refiérase a la figura 1):

- Gotas gruesas: 111 (sin considerar muestras de seguimiento)
- Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por la CCSS: 452

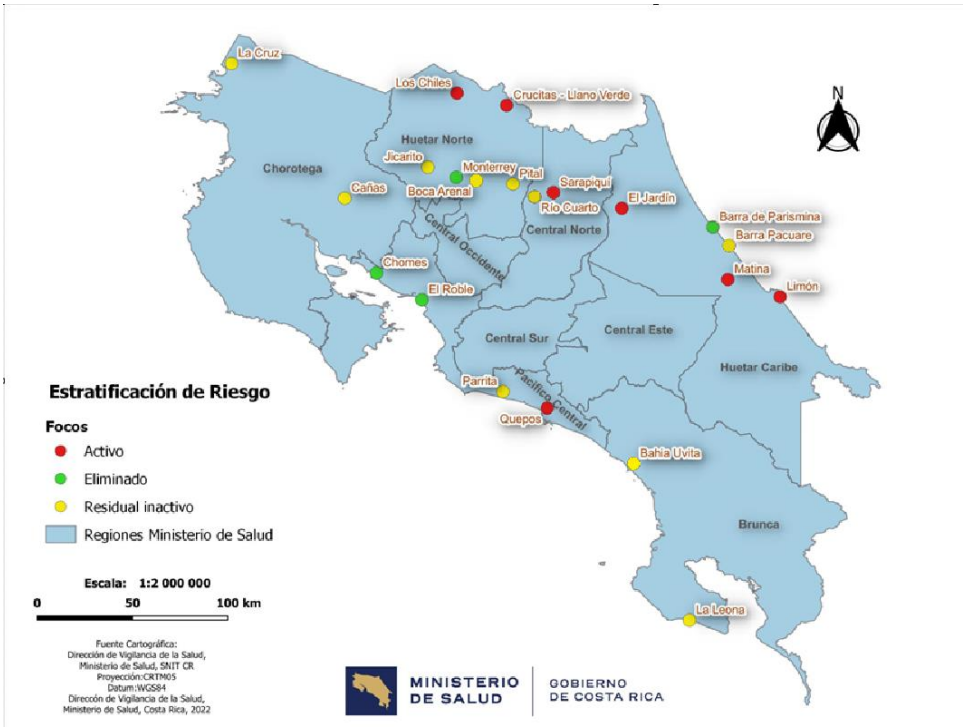
Estas cifras reflejan un esfuerzo coordinado y continuo para identificar y controlar la propagación de la malaria en el país. La combinación del método tradicional como lo es la gota gruesa y las pruebas rápidas permite una detección más amplia y oportuna de casos, contribuyendo significativamente a la vigilancia epidemiológica y al manejo efectivo de esta enfermedad.

Nota: El registro puede incluir datos duplicados, ya que se toman en cuenta las Gotas Gruesas (GG) para medir la parasitemia antes de iniciar el tratamiento, ante una Prueba de Diagnóstico Rápido (PDR) positiva: Inventario de focos.

III. Inventario de focos.

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 7 focos activos, 10 focos residuales inactivos y 4 focos eliminados.

Figura 1.
Costa Rica: Inventario de focos de Malaria a Enero 2025.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

IV. Clasificación del estado histórico y actual de los focos maláricos.

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

Tabla 1.
Costa Rica: Listado de Focos de malaria a Enero 2025, por provincia, cantón y estado actual del foco.

Provincia	Cantón	Nombre del Foco	Estado
Alajuela	San Carlos	Pital	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Boca Arenal	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Monterrey	Eliminado
Alajuela	San Carlos	Crucitas - Llano Verde	Activo
Alajuela	Los Chiles	Los Chiles	Activo
Alajuela	San Carlos	Jicarito	Residual inactivo
Alajuela	Río Cuarto	Rìo Cuarto	Residual inactivo
Guanacaste	La Cruz	La Cruz	Residual inactivo
Guanacaste	Cañas	Cañas	Residual inactivo
Heredia	Sarapiquí	Sarapiquí	Activo
Limón	Matina	Matina	Activo
Limón	Limón	Limón	Activo
Limón	Siquirres	Barra de Parismina	Eliminado
Limón	Pococí	El Jardín	Activo
Limón	Siquirres	Barra Pacuare	Residual inactivo
Puntarenas	Roble	El Roble	Eliminado
Puntarenas	Puntarenas	Chomes	Eliminado
Puntarenas	Quepos	Quepos	Activo
Puntarenas	Parrita	Parrita	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	La Leona	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	Bahia Uvita	Residual inactivo

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19

Roberto Arroba Tijerino
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Mayra Quesada Sanabria
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

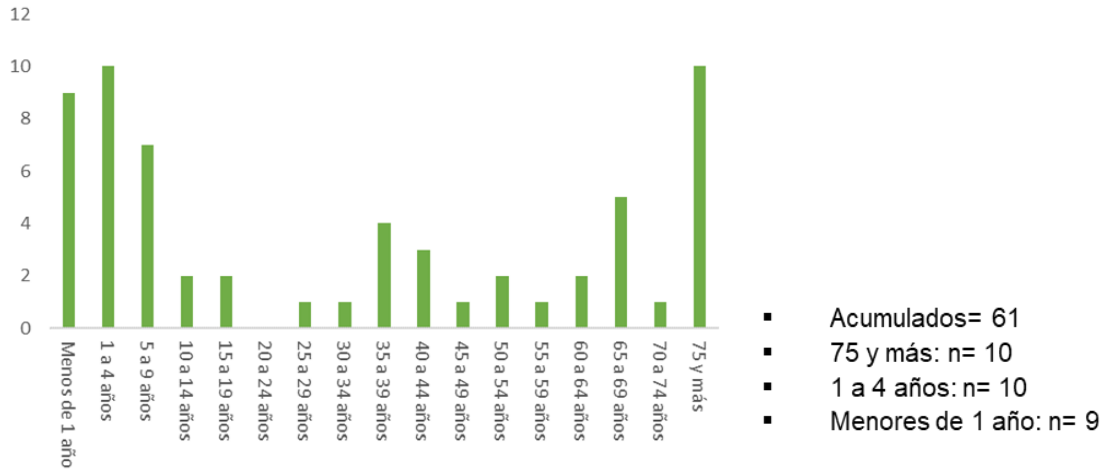
Rafael Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos para la semana epidemiológica 2 de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) y los datos de la semana epidemiológica 2 de las Infecciones Respiratorias Agudas Superiores (IRAS) y la Enfermedad Tipo Influenza (ETI), que según establece el Decreto de Vigilancia de la Salud No. 40556-S del 07 julio del 2017, son eventos de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de las IRAG, por medio de la boleta VE-01, se cuenta con los siguientes datos:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 2 son un total de 61.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en los niños entre 1 y 4 años y en los mayores de 75 años.

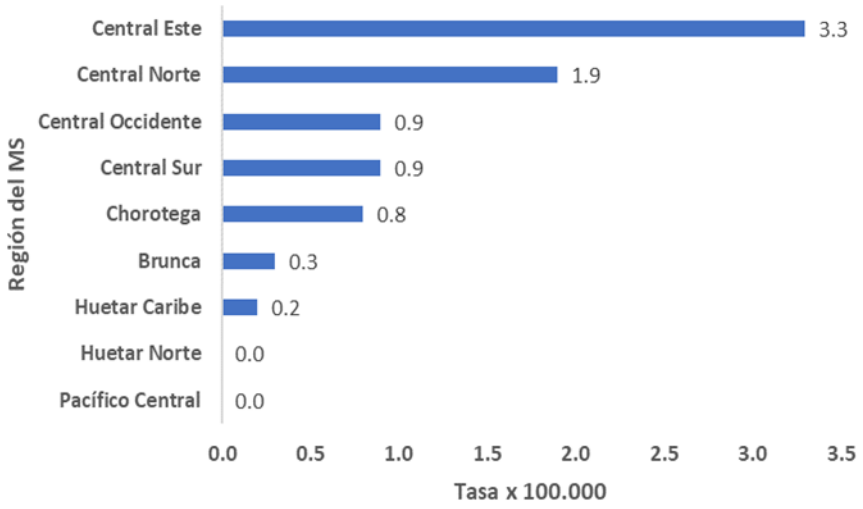
Gráfico 1.
Distribución de casos de IRAG por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 2, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según el gráfico 1, se puede apreciar como en los extremos de la vida (niños entre 1 y 4 años y mayores de 75 años es donde más casos se han presentado).
En el gráfico 2, se observa la tasa de incidencia de IRAG según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 2, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Central Este y Central Norte; las regiones con menor incidencia corresponden a la Central Occidente, la Central Sur, Chorotega, Brunca, Huetar Caribe, Huetar Norte y Pacífico Central.

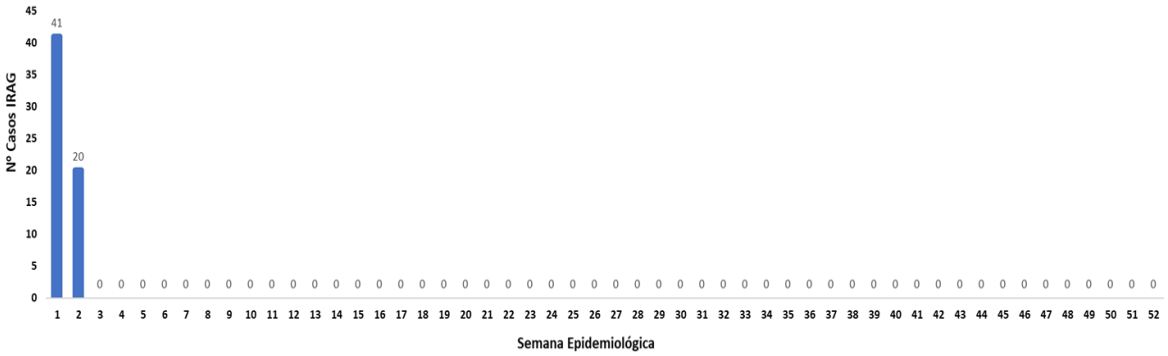
Gráfico 2.
Tasa de IRAG según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 2 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-01 de IRAG, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 3; se puede observar el comportamiento de los casos a la semana epidemiológica 2 del año 2025.

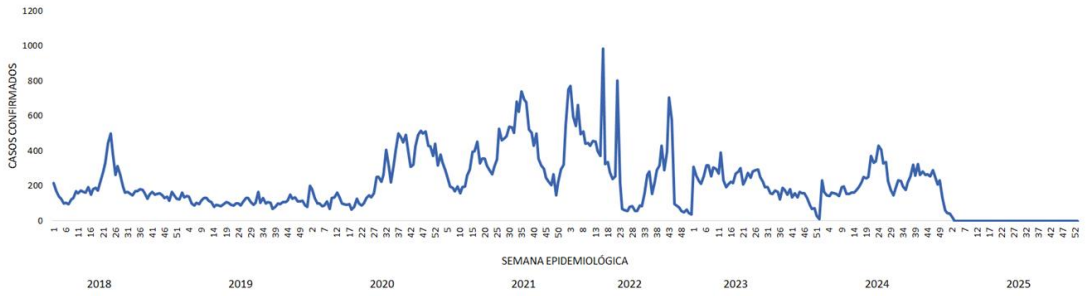
Gráfico 3.
Distribución de casos reportados por boleta VE-01 de IRAG a la semana epidemiológica 52, en Costa Rica, 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAG, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 4.

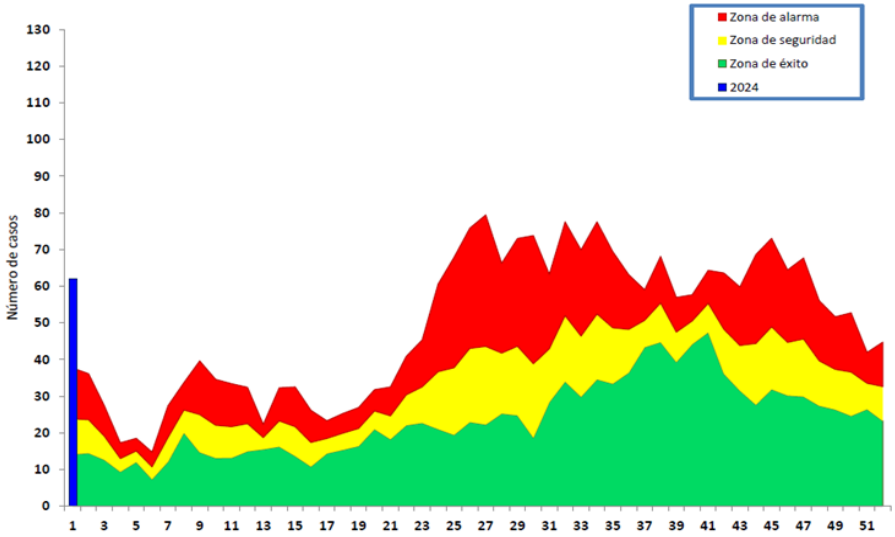
Gráfico 4.
Distribución histórica de casos de IRAG por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

El HNN, para la SE-2 tiene un canal endémico de IRAG que actualmente se encuentra en la zona de alarma debido a la cantidad de casos que están presentando en este momento, tal como se puede apreciar en el gráfico 5.

Gráfico 5.
Costa Rica: Canal endémico IRAG, HNN, 2025

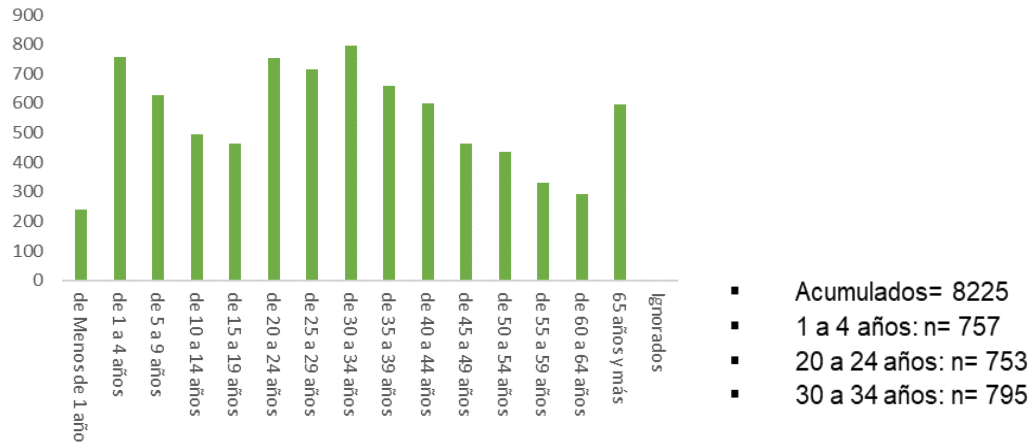


Fuente: Sistemas de Cubos Urgencias-UVEPCI HNN, 2024.

En cuanto a la notificación de IRAS, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 6:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 2 son 8225.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en menores entre 1 y 4 años y personas entre 20 y 24 años.

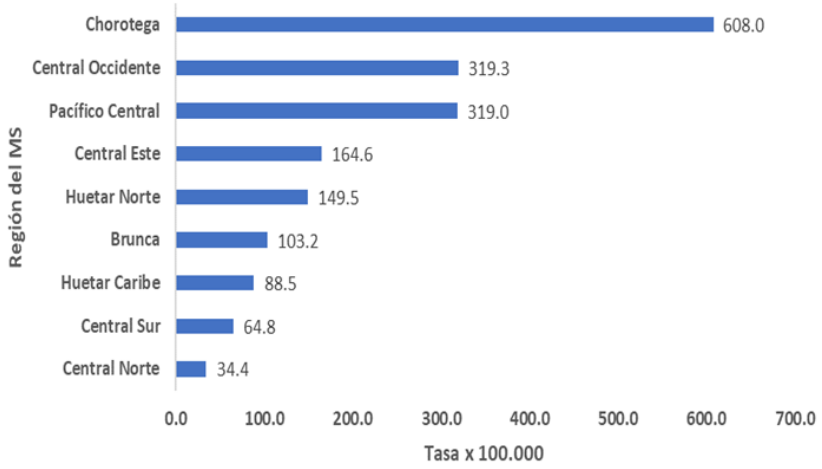
Gráfico 6.
Distribución de casos de IRAS por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 2, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 7, se observa la tasa de incidencia de IRAS según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 2, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Chorotega, la Central Occidente y Pacífico Central. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Central Este, Huetar Norte, Brunca, Huetar Caribe, Central Sur y Central Norte.

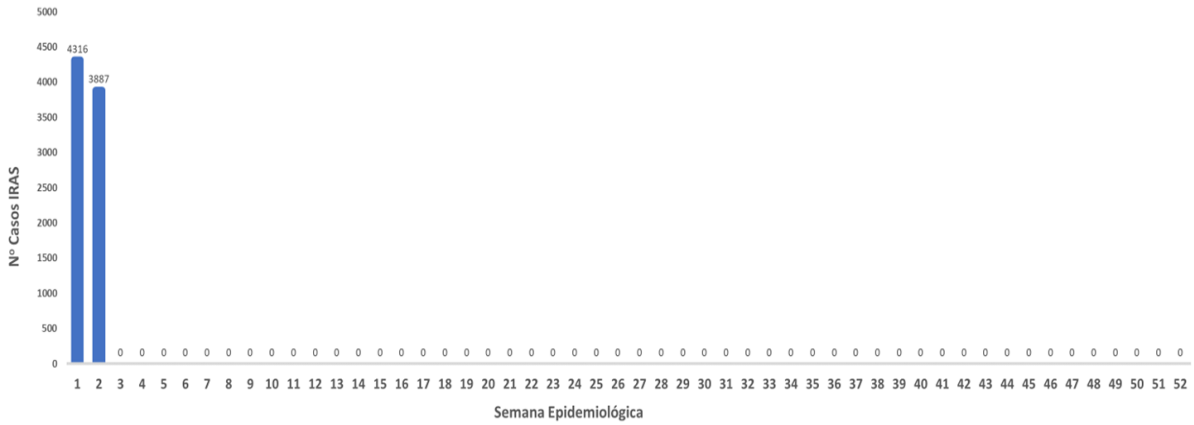
Gráfico 7.
Tasa de IRAS según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 2 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de IRAS, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 8; se puede observar cómo los casos se han comportado a lo largo de estas 2 semanas epidemiológicas del año 2025.

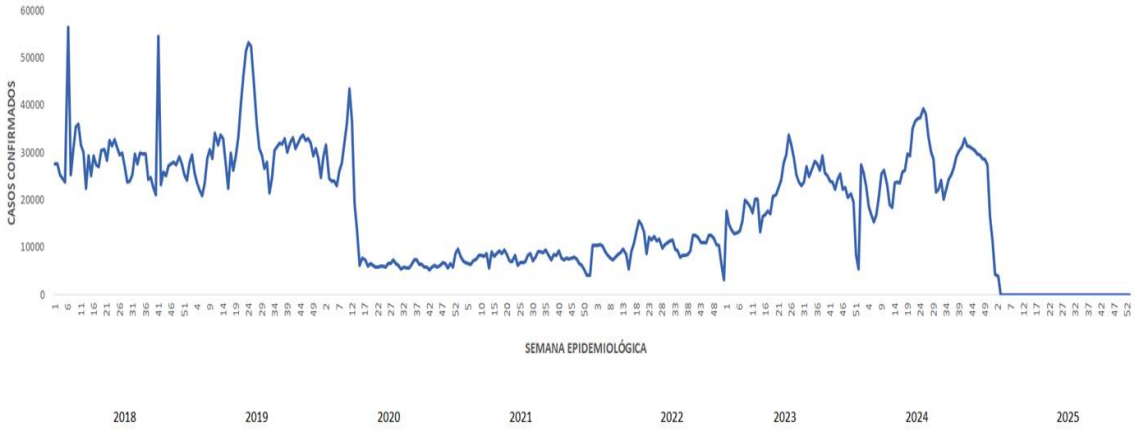
Gráfico 8.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de IRAS a la semana epidemiológica 2, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAS, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 9.

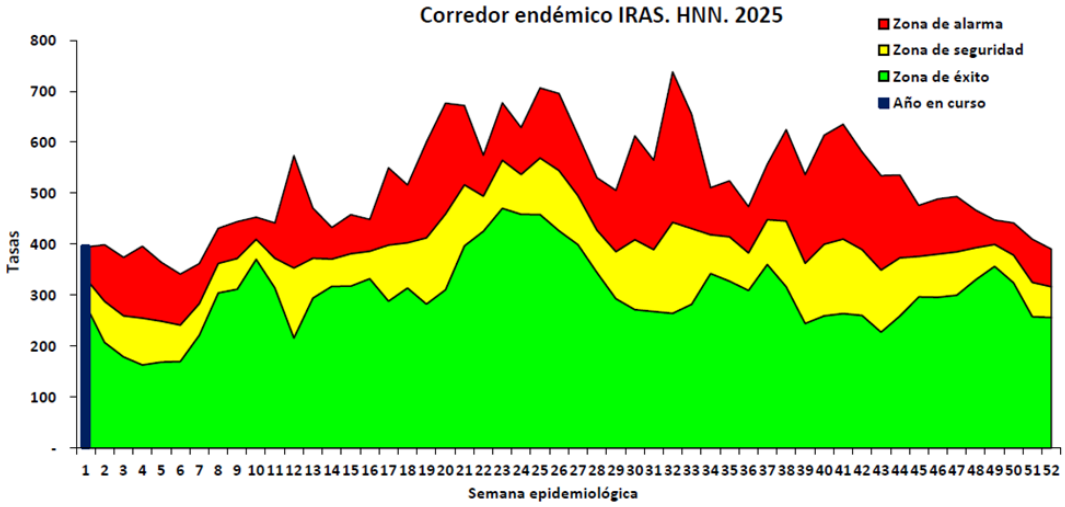
Gráfico 9.
Distribución histórica de casos de IRAS por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 10 se presenta el canal endémico de las IRAS en el Hospital Nacional de Niños, que muestra que a la semana 2 se encuentran en la zona de seguridad actualmente.

Gráfico 10.
Costa Rica: Canal endémico IRAS. HNN. 2025.

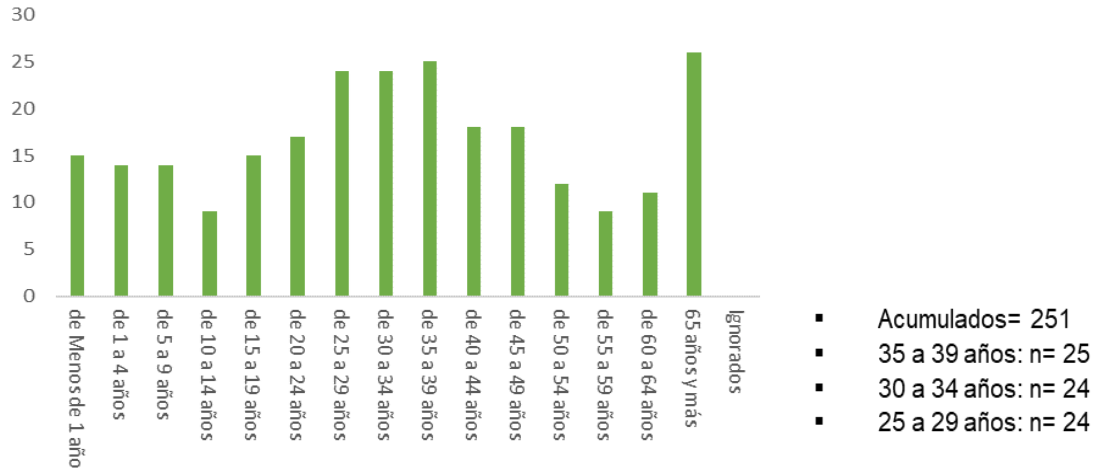


Fuente: Sistemas de Cubos Urgencias-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de ETI, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 11:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 2 son n= 251.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en personas entre 30 y 34 años y las personas entre 35 y 39 años.

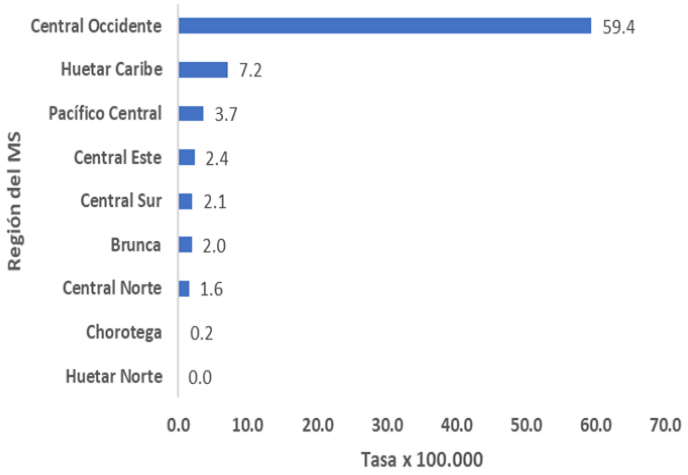
Gráfico 11.
Distribución de casos de ETI por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 2, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 12, se observa la tasa de incidencia por ETI, según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 2, presentando mayor cantidad de casos en la región la Central Occidente. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Brunca, Chorotega, Central Este, Central Sur, Huetar Norte, Pacífico Central, Central Norte y Huetar Caribe.

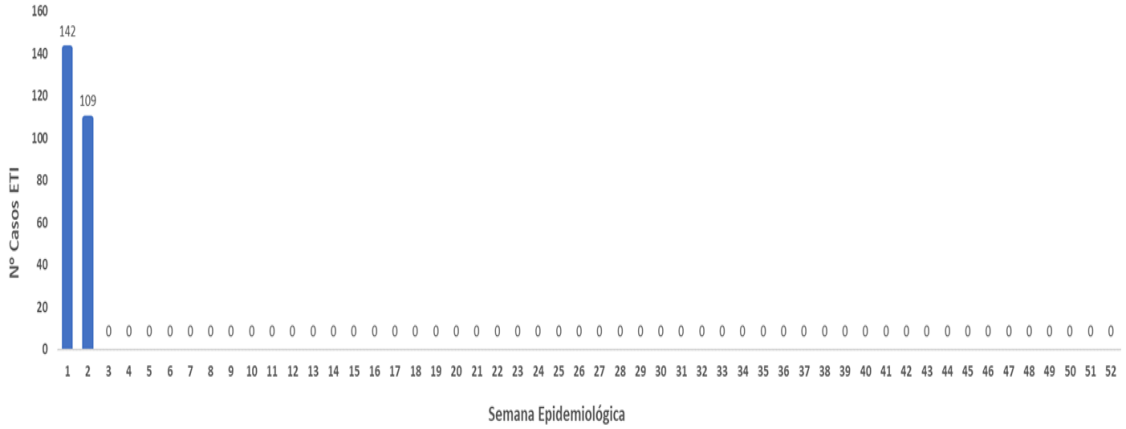
Gráfico 12.
Tasa de ETI por región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 2 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de ETI, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 13; se puede observar cómo se han distribuido los casos en el año 2025.

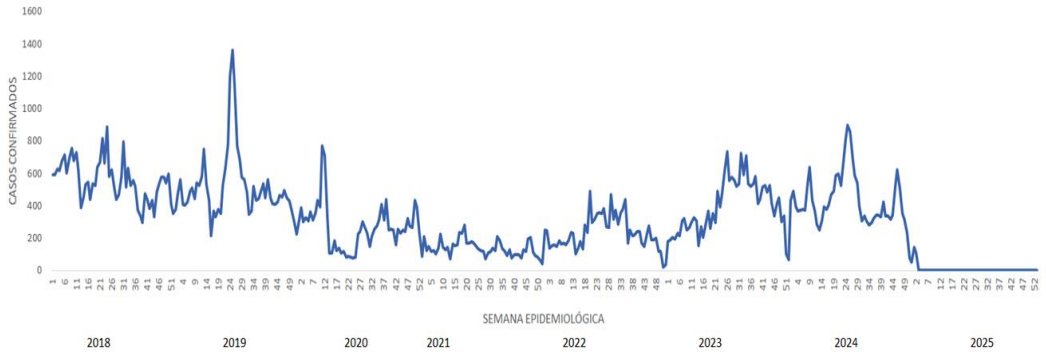
Gráfico 13.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de ETI a la semana epidemiológica 2, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de ETI, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 14.

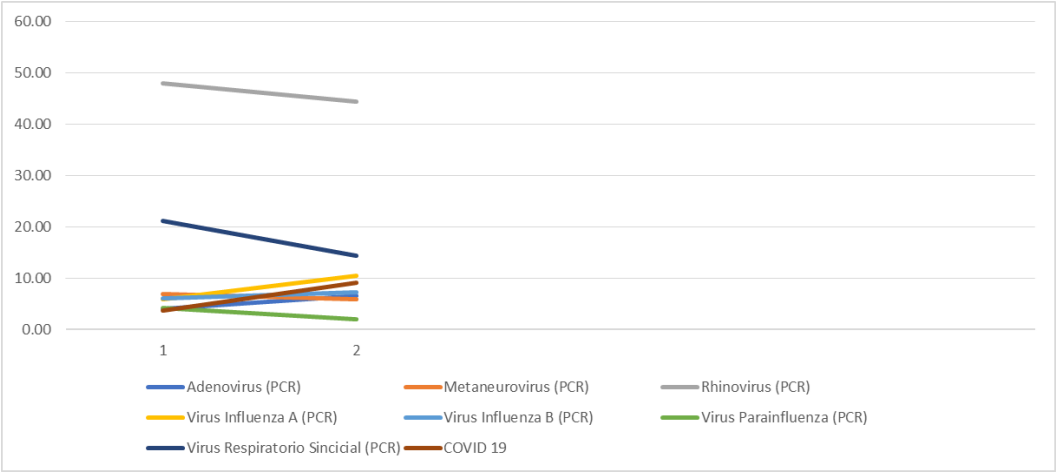
Gráfico 14.
Distribución histórica de casos de ETI por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según se observa en el gráfico 15, se puede ver el comportamiento de los principales virus respiratorios circulantes de la semana 01 a la 02; para la SE-2, en el país el Rinovirus es el que más está circulando, seguido del Virus Sincicial Respiratorio, y finalmente, el virus de influenza A está en tercer lugar de circulación.

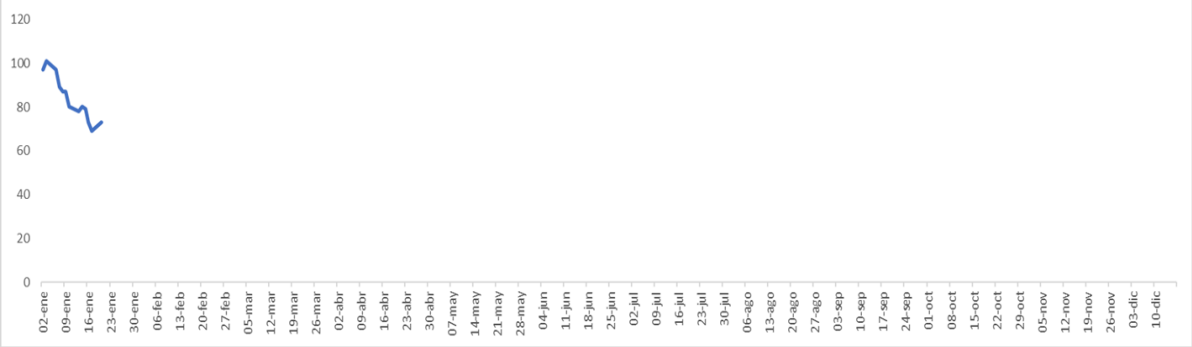
Gráfico 15.
Distribución de virus circulantes de la semana epidemiológica 01 a la 2 en Costa Rica, 2025.



Fuente: Matriz de Resultados de Laboratorio CCSS, Subárea de Vigilancia Epidemiológica 2025.

En relación con los datos específicos del Hospital Nacional de Niños, la situación que se ha presentado a la semana 2 del año 2025 es la siguiente:
Al 20 de enero del año en curso, correspondiente a la semana 3, el total de pacientes respiratorios hospitalizados son 71, lo que corresponde a un porcentaje de ocupación del 81.6%.

Gráfico 16.
Total de pacientes hospitalizados y en emergencias en la semana 3 del año 2025, Hospital Nacional de Niños.



Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2025.

Como observaciones finales se puede indicar lo siguiente:

- IRAG con 61 casos a la semana 2.
- IRAS con 8225 casos a la semana 2.
- ETI con 251 casos reportados a la semana 2.
- Actualmente, la ocupación de camas respiratorias en el HNN es de un 81.6%
- En SE-2, el Rinovirus es el virus que más ha circulado, seguido del Virus Sincicial Respiratorio y en tercer lugar circula el virus de influenza A.

Para la enfermedad por COVID-19, durante la semana epidemiológica 3, se reportaron un total de 66 casos confirmados, lo que representa un aumento del 60% con respecto a la SE-2 del año 2025.

Con respecto a las hospitalizaciones en la semana epidemiológica 3, se reportó un promedio total de 3 hospitalizados, lo que representa un aumento del 50% respecto a la SE-2 del año 2025.

Gráfico 17.
Costa Rica: Promedio total de hospitalizados en salón y Unidad de Cuidados Intensivos, según reporte semanal año 2025.

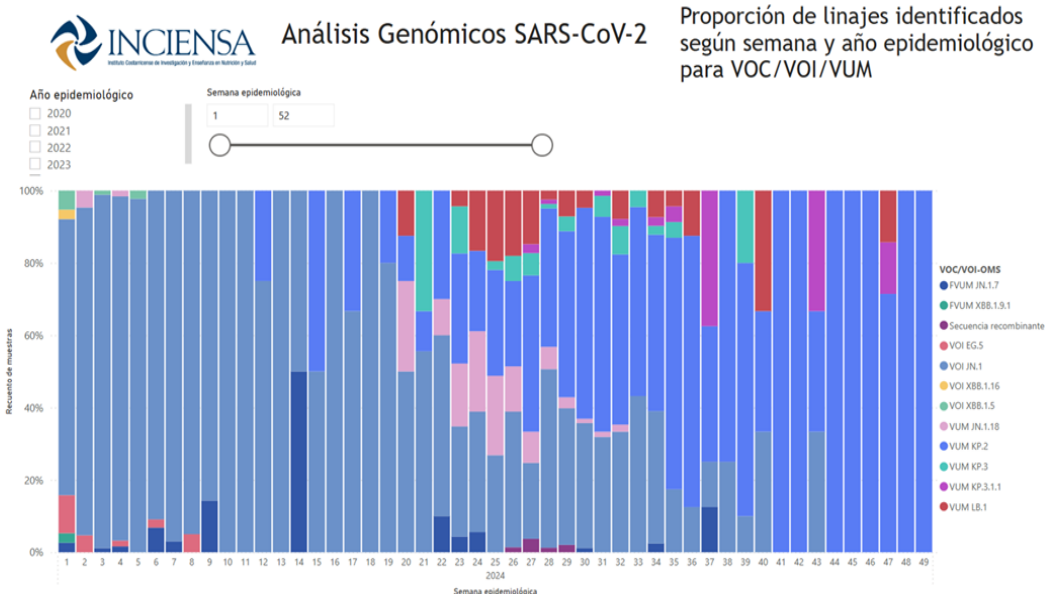


Datos sujetos para actualizar
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS/Dirección de Vigilancia de Salud, Ministerio de Salud, 2025.

En relación con el comportamiento de las personas fallecidas asociadas a COVID-19, durante la semana epidemiológica 3, no hubo fallecidos; sin embargo, es importante indicar que estos son datos preliminares sujetos a la revisión de los casos.
Para la semana epidemiológica 3 no se reportaron brotes asociados a COVID-19.

Variantes genómicas
Según el informe interactivo de INCIENSA revisado el 24 de enero del 2025, se reporta lo siguiente según lo indicado. (Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, 2025).

Gráfico 18.
Costa Rica: Proporción de linaje identificados, para Variante de Preocupación (VOC) Ómicron, Variante de Interés (VOI) y Variantes Bajo Monitoreo (VUM), por semana epidemiológica SE 1 a 49 del 2024.



Fuente: Sistema de Información de INCIENSA, CCSS, DATOS Facultad de Microbiología UCR, actualizado en informe interactivo en Vigilancia genómica SARS-CoV-2 al 24 de enero del 2025.

En relación con la proporción relativa de sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el periodo comprendido entre las SE-1 y 49 del año 2024, se tiene la siguiente información.

Cuadro 1.
Costa Rica: Proporción relativa de Sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el período de las semanas epidemiológicas 1 a 49 de 2024

Linaje Pangolin	Cantidad	%
LB.1	65	5.14
EG.5	10	0.79
XBB.1.16	1	0.08
JN.1*	679	53.68
XBB.1.5.	4	0.32
XBB.1.9.1	1	0.08
JN.1.7	16	1.26
KP.2	379	29.96
KP.3	36	2.85
KP.3.1.1	12	0.95
Secuencia recombinante	7	0.55
JN.1.18	55	4.35
Total	1265	100.00

Fuente: INCIENSA, informes interactivos de variantes genómicas, corte 24 de enero 2025.

Bibliografía

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. (2025). *Informe Interactivo de Vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2 semana 49.* San José: INCIENSA. Obtenido de https://inciensa.sa.cr/Vigilancia%20genomica%20SARS-CoV-2.aspx

Infecciones de transmisión sexual

Pamela Domínguez Saavedra
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Stephany Alvarado Garita
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), son de reporte obligatorio según el Reglamento de Vigilancia de la Salud 40556-S, por consiguiente, la vigilancia es relevante para la salud pública del país. Para el inicio del año 2025, se han reportado las siguientes ITS: Sífilis en todas sus formas, Gonorrea y Herpes Virus y Virus del Papiloma Humano, al corte de la semana 2 del año en curso.

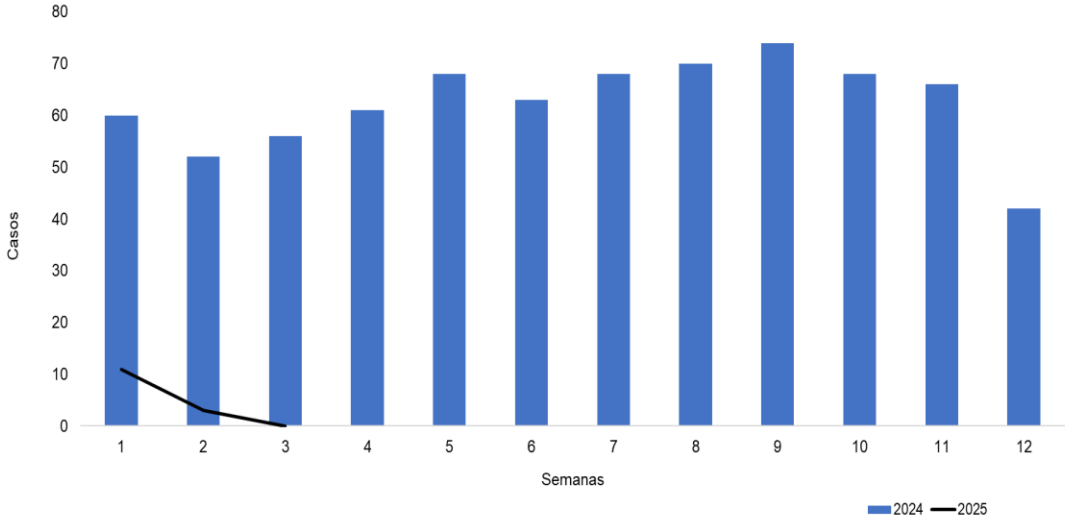
Sífilis en Todas sus Formas

Es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria llamada *Treponema pallidum*, la cual es totalmente prevenible y tratable. Esta infección se trasmite por relaciones sexuales sin protección y de la madre al bebé duranre el embarazo. Por ende, esta infección afecta a la morbilidad y mortalidad de un país.

La Organización Panamericana de la Salud en mayo del 2024 informó que en la región de las América la Sífilis incrementó en un 30 % entre los años 2020 y 2022, en las personas de 15 a 49 años. (OPS, 2024)

Para las primeras semanas del 2025 en Sífilis en todas sus formas se han confirmado 14 casos con una tasa menor 1 por 100 000 habitantes, en el mismo periodo del año 2024 se reportaron 60 casos, lo que representa para el año 2025 un descenso del 44,5% con 46 casos. En el gráfico 1, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 1.
Costa Rica: Casos confirmados por Sífilis en todas sus formas, según fecha de inicio de síntomas en el reporte semanal, años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento de Sífilis en todas sus formas, en estas primeras 2 semanas del año, se han reportado en hombres un 64,29% de los casos (9/14), con una tasa de 0,3 por 100 000 habitantes, el comportamiento en las mujeres se presentó con el 35,71% de los casos (5/14) con una tasa de 0,2 por 100 000 habitantes.

Los casos confirmados según grupos de edad, el de 20 a 64 años presenta más casos con 78,57% (11/14), seguidos por el grupo de menores de 1 año con 2 casos y los mayores de 65 años con 1 caso, los otros grupos no reportan casos. En el cuadro 1, se presentan los casos confirmados según reporte por provincias.

Cuadro 1
Costa Rica: Casos confirmados por Sífilis en todas sus formas, según provincias. Número absoluto y tasas. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 2 del 2025

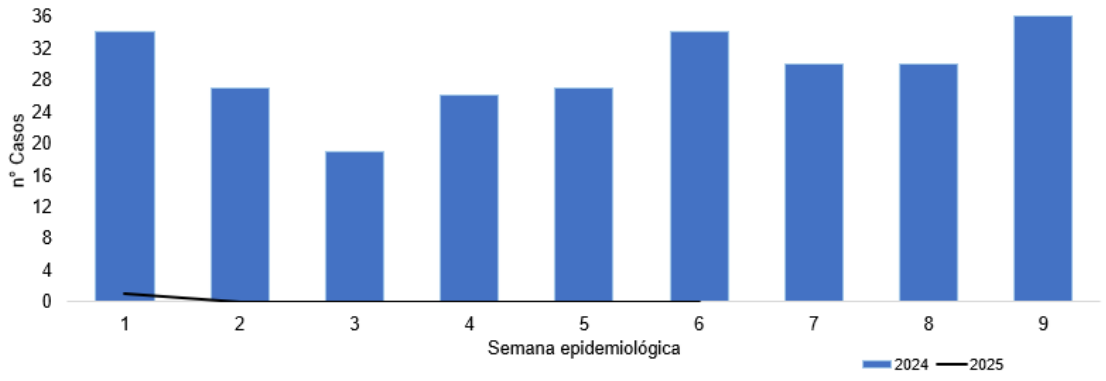
Provincias	Nº	Tasa
San José	4	0,2
Alajuela	4	0,4
Cartago	3	0,5
Heredia	0	0,0
Guanacaste	0	0,0
Puntarenas	1	0,2
Limón	2	0,4
Total	14	0,30

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Gonorrea

Es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria llamada *Neisseria gonorrhoeae*, la cual es totalmente prevenible y tratable. Esta infección se trasmite por relaciones sexuales sin protección y de la madre al bebé duranre el parto. Por consiguiente, esta infección afecta a la morbilidad del país. En las primeras dos 2 semanas del 2025, se han notificado 1 casos del grupo de edad de 25 a 29 años de la provincia de Alajuela. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 34 casos. El gráfico 2, muestra el comportamiento según reporte semanal.

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados por Gonorrea, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años años 2024 y 2025

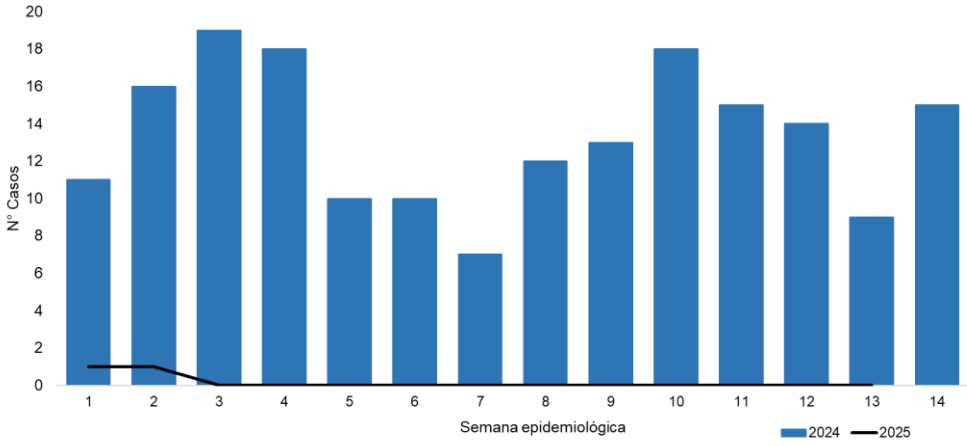


Nota: Los datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Herpes Virus

El Herpes Virus es otra de las Infección de transmisión sexual, que se ha reportado en las primeras 2 semanas del año en curso, con 2 casos en mujeres entre los grupos de edad 20 a 24 años y 55 a 59 años, un caso de la provincia de San José y el otro en Limón

Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados por Herpes virus, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025

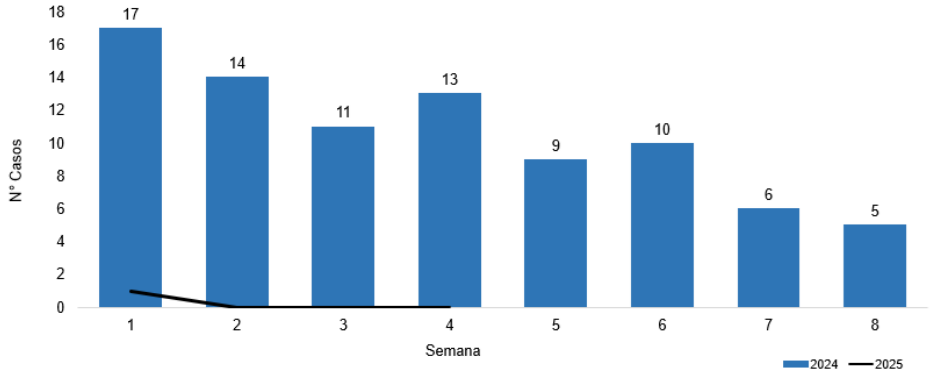


Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus del Papiloma Humano (VPH)

El VPH es otra de las Infección de transmisión sexual, en las primeras 2 semanas del 2025 se ha notificado 1 casos del grupo de edad 15 a 19 años de la provincia de San José. En el año 2024, se notificaron 17 casos. El gráfico 4 presenta el comportamiento según reporte semanal.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados por Virus del Papiloma Humano, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizados.
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, 2024.

Bibliografía
OPS, OMS. (22 de mayo de 2024). *Los casos de sífilis aumentan en las Américas*. Obtenido de https://www.paho.org/es/noticias/22-5-2024-casos-sifilis-aumentan-americas

Miasis por gusano barrenador en humanos

María José Lafuente González
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

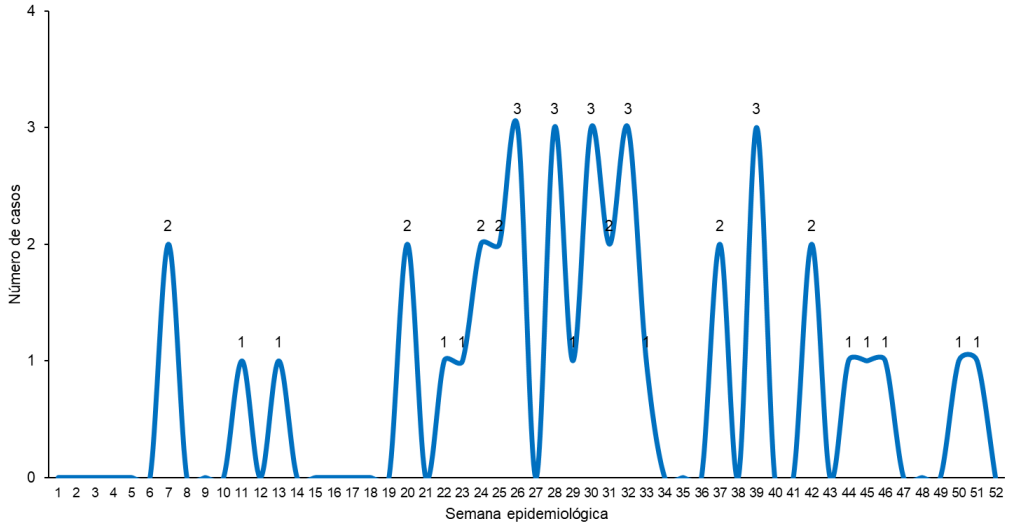
Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos de miasis por gusano barrenador en humanos para la semana epidemiológica 52 del año 2024, según establece el Decreto de Vigilancia de la Salud N°40556-S y el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos es un evento de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de esta miasis, por medio de la boleta VE-01, para el año 2024 a la semana epidemiológica (SE) 52, se tienen los siguientes datos:

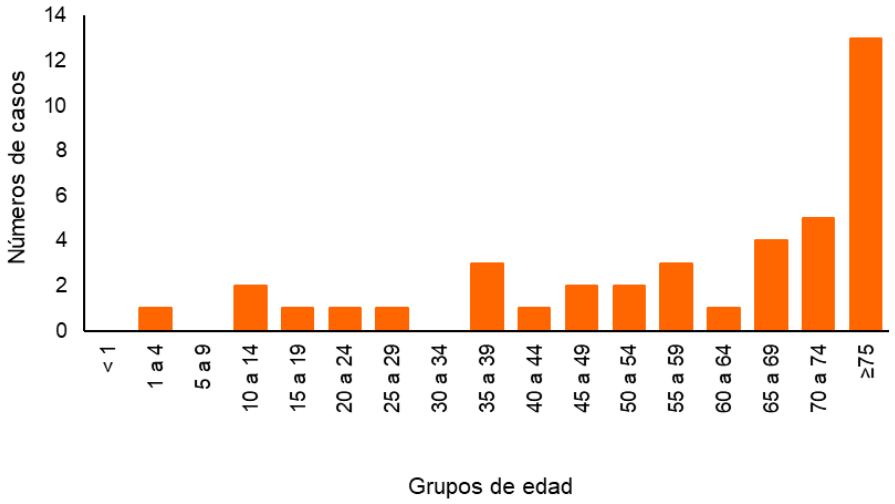
- Casos acumulados de miasis por gusano barrenado en humanos suman un total de 40 casos
- Casos por grupos de edad quinquenal tienen un predominio en las personas adultas de 65 y más años con más casos reportados (22/40)

Gráfico 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador según SE de la 1 a la 52, 2024



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador según grupos de edad quinquenal, de la SE 01 a la 52, 2024



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024

El comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos, en el año 2024, presentó un predominio en los hombres con 26 casos notificados con una tasa de 1,0 por 100.000 habitantes y en las mujeres con 14 casos notificados con una tasa de 0,5 por 100.000 habitantes (Gráfico 2).

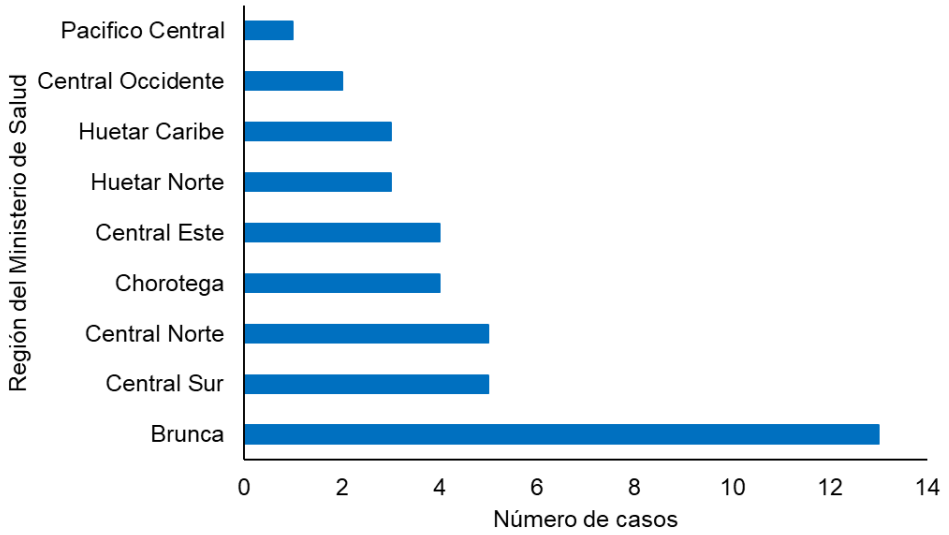
Cuadro 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasas (tasa p/100.000 habitantes) según provincia de procedencia, de la SE 1 a 52, 2024

Provincias	Casos	Tasas
Total	**40**	**0,8**
San José	7	0,4
Alajuela	7	0,6
Cartago	3	0,5
Heredia	3	0,5
Guanacaste	4	1,0
Puntarenas	13	2,5
Limón	3	0,6

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024

En el cuadro 1, se presenta el comportamiento de esta enfermedad por provincia de procedencia, por casos y tasas por 100.000 habitantes notificados a la SE 52, presentando mayor número de casos la provincia de Puntarenas (13/40) seguida por la provincia de San José y Alajuela (7/40).

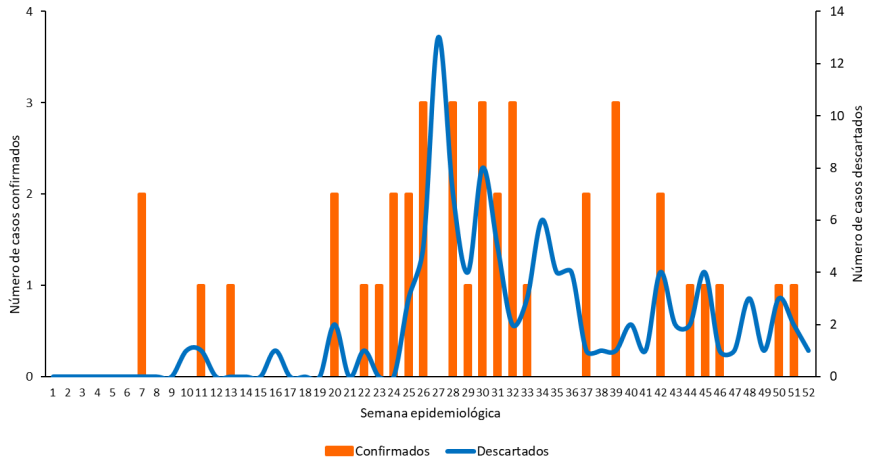
Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos según región del Ministerio de Salud de procedencia, de la SE 1 a 52, 2024



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024

En el gráfico 3, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las nueve regiones del país, siendo la Región Brunca la que presente el mayor número de casos (13/40).

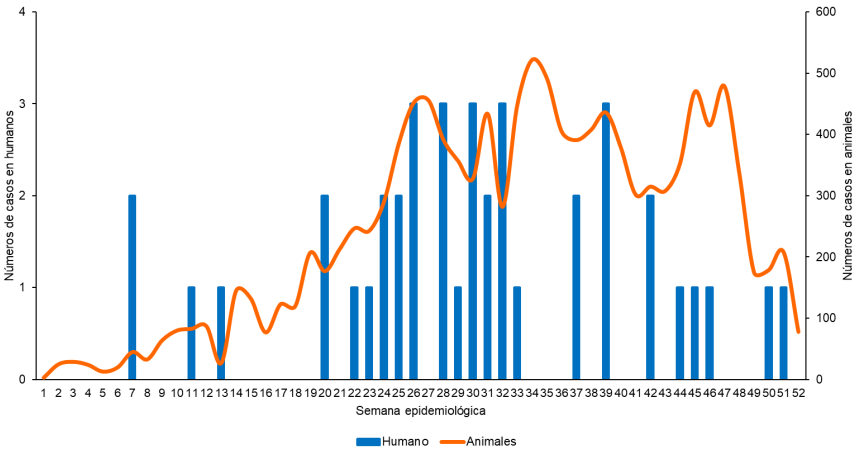
Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados y descartados de miasis por gusano barrenador, de la SE 1 a 52, 2024



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios, SENASA / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024

Para el año 2024, en el gráfico 4 a la semana epidemiológica 52 se brindó atención a 140 casos sospechosos por Miasis de Gusano Barrenador en humanos. Por parte del Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios el 28,57% (40/140) de los casos fueron confirmados y el 71,43% (100/140) de los casos fueron descartados.

Gráfico 5
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador en humanos y animales según SE de la 01 a la 52, 2024



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Boletín Epidemiológico Extraordinario Gusano Barrenador actualizado al 28 de diciembre del 2024, SENASA / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024

En el gráfico 5, se muestran los casos de miasis por gusano barrenador en animales y humanos por SE de la 01 a la 52 del 2024, con 40 casos confirmados en humanos y 12696 casos confirmados en animales.

Es de suma importancia mantener la prevención y control de esta enfermedad, dado que la mosca continúa circulando en el territorio nacional y existe la declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación de la enfermedad de Gusano Barrenador, Decreto Ejecutivo N° 44382–MAG (*Cochliomyia hominivorax*).

Generalidades de prevención y control:

- Mantener higiene personal, lavarse las manos regularmente con agua y jabón
- Control, tratamiento e higiene en lesiones en piel de acuerdo con la recomendación del médico tratante
- Asistir al establecimiento de salud público o privado cuando presente síntomas asociados a la enfermedad, tales como: dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia, se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la lesión herida
- Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, realizando revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas e informar a las autoridades de salud animal (SENASA) sobre la aparición de animales de producción o domésticos con gusaneras

Depresiones

Gloriela Brenes Murillo
Unidad de Epidemiología
Dirección Vigilancia de la Salud

Siany Cordero Abarca
Unidad Seguimiento de Indicadores en Salud
Dirección Vigilancia de la Salud

2025

INTRODUCCIÓN

El trastorno depresivo o depresión es un trastorno mental habitual que puede afectar a cualquier persona. Se caracteriza por un bajo estado de ánimo o una pérdida de interés por realizar actividades o de placer al realizarlas, que duran un periodo prolongado.

La depresión no es lo mismo que los cambios de estado de ánimo o las emociones que podamos tener cotidianamente, ya que los episodios depresivos duran la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos dos semanas. La persona puede tener trastornos del sueño y cambios de apetito, así como disminución de la autoestima, ideas en torno a la muerte y desesperanza respecto al futuro.

La depresión es producto de una compleja interacción de factores sociales, psicológicos y biológicos. Un factor que puede predisponer a sufrirla es haber sufrido malos tratos, haber perdido a un ser querido u otros sucesos adversos. Los problemas escolares y laborales también pueden provocar depresión.

Se ha demostrado que los programas preventivos reducen la incidencia de la depresión. Además, hay tratamientos psicológicos y farmacológicos eficaces.

Síntomas

En un episodio depresivo, la persona experimenta un estado de ánimo deprimido (tristeza, irritabilidad, sensación de vacío) o una pérdida del placer o del interés por actividades y es distinto de las variaciones habituales del estado de ánimo.

Pueden presentarse varios síntomas más, como:

-dificultades para concentrarse

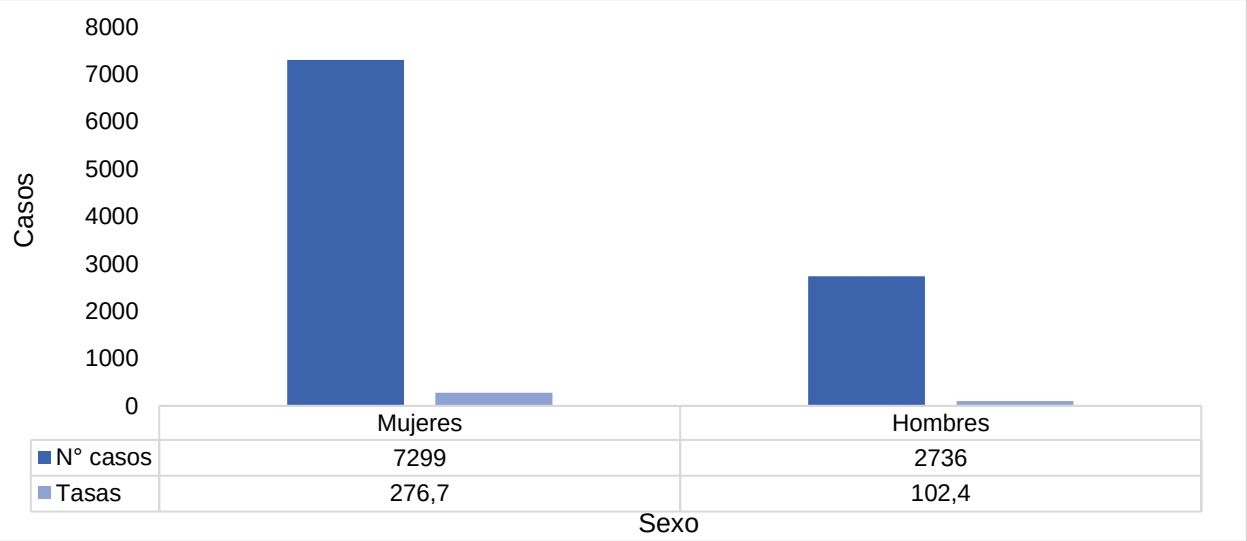
-un sentimiento de culpa excesiva o de baja autoestima
-falta de esperanza acerca del futuro
-pensamientos de muerte o suicidio
-alteraciones del sueño
-cambios en el apetito o en el peso
-sensación de cansancio acusado o de falta de energía.
Es así como con la promulgación del Decreto de Vigilancia 40556-S del año 2017, se incorpora; el trastorno depresivo como enfermedad de diagnóstico en la Boleta de Notificación Individual Obligatoria, VE01, lo cual ha permitido conocer su comportamiento estadístico y epidemiológico.

A continuación, se presenta la información más relevante de las depresiones notificadas en el acumulado a la Semana Epidemiológica N° 52 del año 2024 (finales de diciembre), es importante indicar que son datos que aún se encuentran en estado "preliminar" pero que van conformando la situación de los casos notificados de depresión del año anterior.
Para ello se identificaron las principales variables que desagregadas permiten visualizar mejor el evento en su conjunto, tales como sexo, grupos de edad, provincia, cantón, distrito y tendencias, entre otras.

DEPRESIONES SE52, 2024

Al respecto a la SE52 se tiene un acumulado preliminar de 10035 casos notificados de depresiones, de estos las mujeres cuentan con la mayor cantidad de casos atendidos, en relación con los hombres, lo cual implica una diferencia entre los sexos de más de 4 mil casos, el gráfico N°1 ilustra lo anterior.

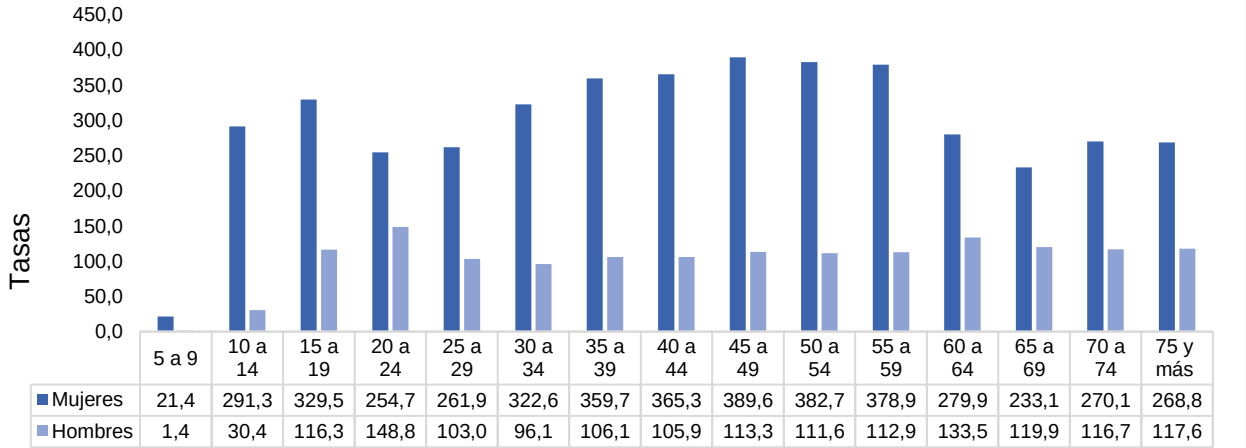
Gráfico 1
Costa Rica: totales e incidencia de casos notificados de depresión según sexo a la SE52, 2024. (tasa por 100 000 habitantes). (*)



(*) Datos preliminares SE52-2024
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

Por otro lado, en cuanto a los datos según los grupos de edad por sexo, las mujeres de todas las edades mantienen la tendencia a lo largo de este año, presentando las tasas más altas con relación a los hombres, siendo las que tiene edades entre los 45-49 las que presentan las tasas más altas, sin embargo, en cuanto a totales de casos; las mujeres con edades entre los 35-39 años tienen el total más alto con 791 casos, seguida de las que se encuentran entre los 45-49 años cuyo total de casos notificados fue de 652 y las mujeres entre los 15-19 con más de 600 casos.
En cuanto a los hombres, se obtuvo que los que se ubican en el grupo de edad de 75 y más tienen la tasa más alta y en relación con los rangos de edad con más casos por totales están en las poblaciones con edades entre los 15-19 años cuyo número aproximado fue de 288 casos notificados.
Finalmente, en cuanto a la tasa nacional en ambos sexos los grupos de edad con la tasa más alta son los grupos de población con edades entre los 55-59 años, el gráfico 2 confirma lo anterior.

Gráfico 2.
Costa Rica incidencia de casos notificados de depresión según grupos de edad y sexo, SE52-2024 (tasa por 100 000 habitantes). (*)

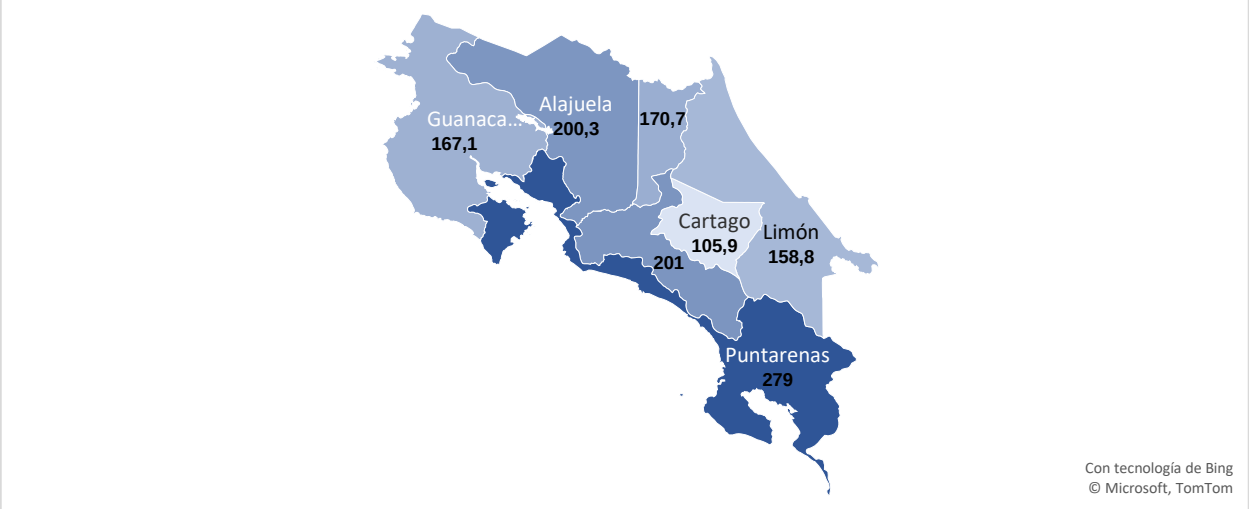


	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 y más
Mujeres	21,4	291,3	329,5	254,7	261,9	322,6	359,7	365,3	389,6	382,7	378,9	279,9	233,1	270,1	268,8
Hombres	1,4	30,4	116,3	148,8	103,0	96,1	106,1	105,9	113,3	111,6	112,9	133,5	119,9	116,7	117,6

(*) Datos preliminares, SE52-2024
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

En cuanto al comportamiento de las depresiones según provincia, actualmente Puntarenas mantiene la tendencia al aumento muy por encima de San José quien la secunda y en una tercera posición está Alajuela, cabe destacar que están tres provincias mantienen este comportamiento a lo largo del año, el Mapa 1 confirma lo indicado.

Mapa 1.
Costa Rica: incidencia de casos notificados de depresión según provincia, SE52, 2024 (tasa por 100 000 habitantes) (*)



(*) Datos preliminares, SE52-2024
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

La siguiente tabla brinda la información del número de casos acumulados por provincia, nótese que San José tiene la mayor cantidad de casos notificados, para Pardo, Silvia de INFOBAE, esta relación entre la densidad poblacional y los casos de depresión puede explicarse por varios factores:

-Estrés y presión social: En áreas con alta densidad de población, las personas suelen enfrentar más competencia laboral, presión académica y estrés financiero, lo que puede contribuir a la depresión.

-Aislamiento social: Paradójicamente, vivir en una ciudad grande puede llevar a sentimientos de soledad y aislamiento, ya que las interacciones pueden ser más superficiales y menos significativas.

-Contaminación y ruido: La exposición constante a altos niveles de ruido y contaminación en áreas urbanas puede afectar negativamente la salud mental.

-Acceso a servicios de salud: En áreas urbanas, hay más acceso a servicios de salud mental, lo que puede resultar en un mayor diagnóstico y reporte de casos de depresión.

-Desigualdad económica: Las grandes ciudades a menudo tienen una mayor desigualdad económica, lo que puede aumentar el estrés y la ansiedad entre las personas de menores ingresos.

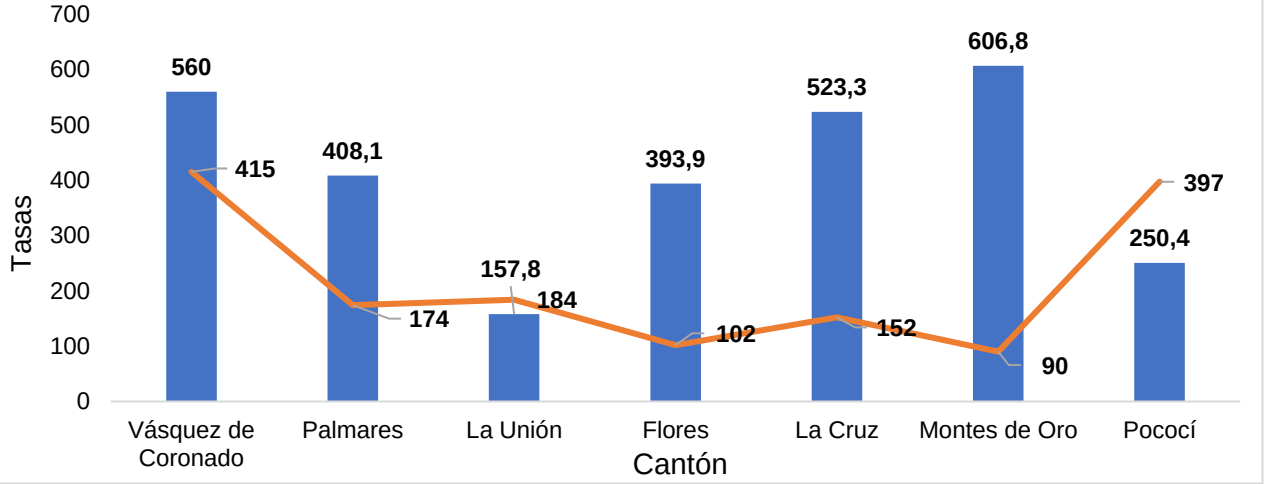
Tabla 1.
Costa Rica: totales de casos notificados de depresión según provincia. SE52, 2024. (*)

Provincia	N° casos
Nacional	***10035***
San José	3431
Alajuela	2164
Cartago	586
Heredia	943
Guanacaste	694
Puntarenas	1456
Limón	761

(*) Datos preliminares, SE52-2024
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

En cuanto a la situación por cantones, Montes de Oro que pertenece a Puntarenas registra la tasa más alta, le sigue muy de cerca Vásquez de Coronado en San José, y en una tercera posición se ubica La Cruz en Guanacaste.

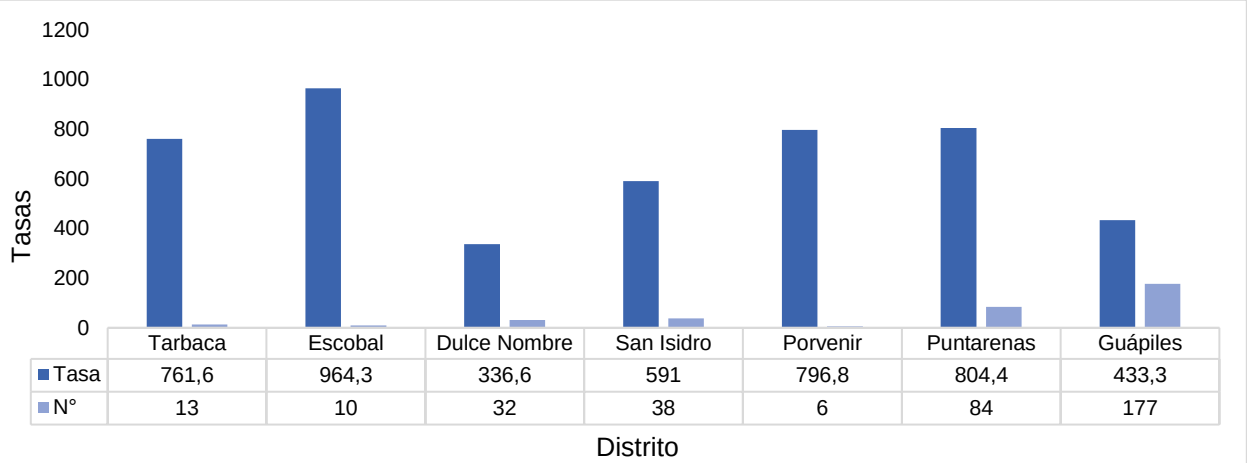
Gráfico 3.
Costa Rica: incidencia de casos notificados de depresión según cantón, SE52, 2024 (tasa por 100 000 habitantes). (*)



(*) Datos preliminares, SE52-2024
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

Con relación a la información acumulada del comportamiento según los distritos a la SE52, Escobal de Atenas obtiene la tasa más alta, seguido por el distrito de Puntarenas en Puntarenas y en una tercera posición Porvenir del cantón de Nandayure en Guanacaste.

Gráfico 4.
Costa Rica: incidencia de casos notificados de depresión según distrito, SE52, 2024 (tasa por 100 000 habitantes). (*)



	Tarbaca	Escobal	Dulce Nombre	San Isidro	Porvenir	Puntarenas	Guápiles
Tasa	761,6	964,3	336,6	591	796,8	804,4	433,3
N°	13	10	32	38	6	84	177

(*) Datos preliminares, SE52-2024
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

En cuanto a los reportes según las Regiones Rectoras de Salud, la Región Central Sur por la densidad de población tiene la mayor cantidad de casos ya que hay un mejor acceso a servicios de salud, entre otros servicios y atenciones, sin embargo, como ha sido usual la Región Huetar Norte tiene la tasa más alta de notificaciones, información que se detalla en la Tabla 3.

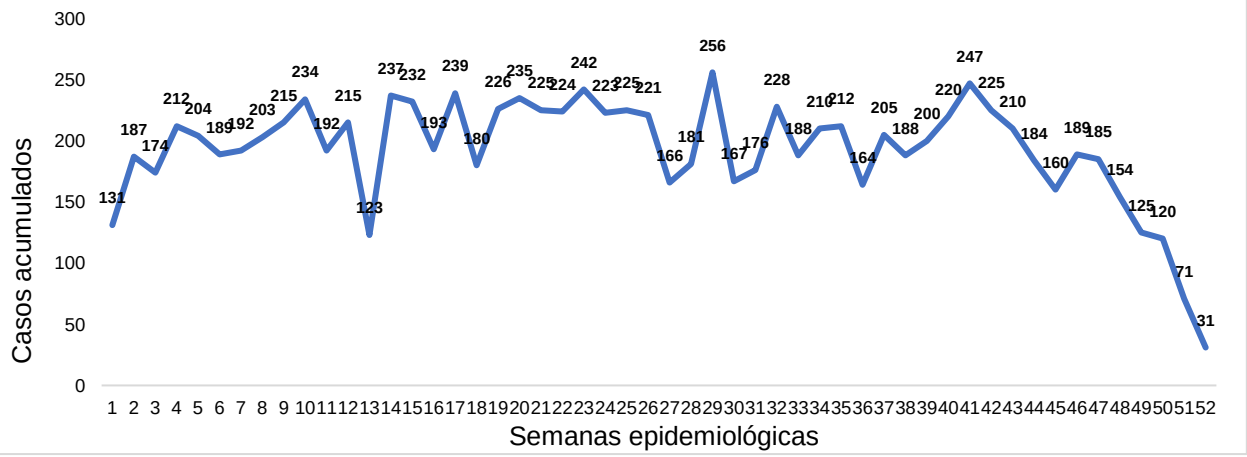
Tabla 3.
Costa Rica: incidencia y totales de casos notificados de depresión según Región Rectora de Salud, SE52, 2024 (tasa por 100 000 habitantes). (*)

Región	N° de casos	Tasa
Nacional	***10035***	***189,0***
Brunca	750	198,9
Central Este	653	113,6
Central Norte	1569	150,0
Central Sur	3152	204,4
Chorotega	784	166,1
Huetar Caribe	761	158,8
Huetar Norte	771	287,0
Central Occidente	599	261,8
Pacífico Central	996	310,8

(*) Datos preliminares, SE52-2024
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

Finalmente, en el acumulado la tendencia de este evento hasta la SE52, es irregular con picos altos en las SE 29 (mediados de julio) y 41 (inicios de octubre) respectivamente.

Gráfico 4.
Costa Rica: tendencia de casos notificados de depresión según semana epidemiológica, SE52, 2024 (*)



(*) Datos preliminares, SE52-2024
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud